

GUIA RÁPIDO DE ESTUDO

Manejo odontológico do paciente com TEA nível 3, TDAH e TAG

1. AS TRÊS CONDIÇÕES

Condição	O que é	O que atrapalha no consultório
TEA nível 3	Transtorno do neurodesenvolvimento que afeta comunicação, interação social e comportamento. Nível 3 = exige apoio muito substancial (DSM-5).	Comunicação verbal mínima e hiper-reatividade sensorial: luz, ruído, cheiro e toque são sentidos de forma intensificada.
TDAH	Desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade. Três apresentações: desatenta, hiperativa-impulsiva e combinada.	Não permanece parada na cadeira, não aguarda, não segue instrução sequencial. Em casa, falha a rotina de escovação.
TAG	Preocupação excessiva por 6 meses ou mais. Na criança aparece como irritabilidade, queixa física, choro e recusa.	Antecipação: a criança já chega em estado de alerta, antes de qualquer procedimento.

Cada transtorno derruba um pilar diferente do manejo — e o manejo depende dos três. A coexistência é comum: metanálise da Lancet Psychiatry (2019) encontrou TDAH em 28% e transtornos de ansiedade em 20% das pessoas com TEA; em amostras clínicas, muito mais.

2. O QUE ISSO CAUSA NA BOCA

A condição em si não causa cárie. Causa a cadeia de fatores que vem junto — saiba enumerar:

- Higiene dependente do cuidador, que nem sempre foi orientado.
- Hipersensibilidade oral: o toque da escova é aversivo, a criança recusa, o biofilme acumula.
- Seletividade alimentar: dieta pastosa, repetitiva e açucarada, com alta frequência.
- Hipossalivação medicamentosa: estimulantes (metilfenidato), antipsicóticos (risperidona) e ISRS (sertralina) reduzem o fluxo salivar; estimulantes e ISRS também causam bruxismo.
- Acesso difícil: consultas desmarcadas, equipe sem treinamento, diagnóstico tardio.

Também são frequentes bruxismo, traumatismo dentário e, no TEA nível 3, autolesão por mordedura de lábio e mucosa.

3. COMO CONDUZIR O ATENDIMENTO

Antes: anamnese ampliada com o responsável

Como a criança se comunica · qual a rotina e o melhor horário · o que a incomoda · o que a acalma · como é a escovação e a alimentação em casa · experiências anteriores no dentista · medicamentos, doses e horários. Essas respostas são o plano de tratamento, não formalidade.

Previsibilidade — o princípio que organiza tudo

- Consultas curtas: três de 15 minutos valem mais que uma de 45.
- Mesmo horário, mesma sala, mesma equipe. Trocar o operador pode zerar o progresso.
- Primeira consulta só de adaptação, sem procedimento. É o que faz a segunda acontecer.

Condicionamento gradual

- Dessensibilização: aproximação repetida e progressiva — entrar na sala, sentar, ver o espelho, encostar na mão, na bochecha, na boca. Só avança quando a etapa anterior é tolerada.
- Dizer-mostrar-fazer: explicar, demonstrar, executar. No nível 3 o "dizer" se apoia na imagem.
- Pedagogia visual: agenda visual da consulta em figuras, pranchas de comunicação, PECS, TEACCH e histórias sociais. É o recurso com melhor evidência.
- Modelagem por vídeo: a criança assiste em casa a alguém passando pelo procedimento.
- Reforço positivo imediato a cada etapa cumprida, com algo que importa para aquela criança.

Ambiente sensorialmente adaptado

Reduzir luz do refletor e oferecer óculos escuros · abafador de ruído ou música calma · evitar eugenol e odores fortes · coleto ou cobertor com peso · tirar do campo de visão o instrumental que não será usado · manter o cuidador na sala.

4. QUANDO ESCALAR, E A ORDEM

A AAPD separa manejo básico de avançado. O avançado só entra depois da falha do básico, sempre com consentimento informado e registro em prontuário.

A escada: 1) manejo básico e prevenção → 2) adaptação do ambiente → 3) dessensibilização em várias sessões → 4) óxido nitroso → 5) estabilização protetora, se indicada → 6) sedação moderada ou profunda → 7) anestesia geral. Sobe-se um degrau por vez.

Sobre a estabilização protetora: só quando necessário para proteger a criança e a equipe, sempre na técnica menos restritiva, com consentimento e registro. Nunca por pressa e nunca como punição.

5. PREVENÇÃO — O QUE MUDA O DESFECHO

Escovação supervisionada pelo cuidador, com técnica e posição orientadas (joelho a joelho) · escova elétrica, testando a tolerância à vibração · creme fluoretado em quantidade adequada · verniz fluoretado periódico · selantes · diamino fluoreto de prata, que paralisa a lesão sem preparo cavitário (escurece, precisa ser consentido) · ART, sem alta rotação · orientação dietética focada em frequência · retornos curtos e frequentes.

6. NÚMEROS E ESTUDOS PARA CITAR

Dado	Fonte
Crianças com TDAH têm OR 3,31 (IC 95% 1,25–8,73) para cárie	Drumond et al., 2022 — metanálise
Ambiente adaptado reduz estresse fisiológico e comportamental em todas as fases da consulta	Stein Duker et al., 2023 — ECR cruzado, 162 crianças
Pedagogia visual melhora cooperação e qualidade da escovação	Balian et al., 2021 — metanálise
Modelagem por vídeo reduz o número de consultas necessárias	Da Silva Moro et al., 2024 — ECR brasileiro
Evidência das técnicas é favorável, mas inconclusiva quanto à força	AlBhaisi et al., 2022 — revisão sistemática
Manejo básico x avançado e critérios para escalar	AAPD, 2024 — diretriz
TEA em 1 a cada 31 crianças de 8 anos	CDC, 2025 (ano de vigilância 2022)

7. SEIS PERGUNTAS PROVÁVEIS

Por que não sedar logo, já que a paciente não colabora?

A AAPD coloca sedação e anestesia geral como manejo avançado, depois da falha do básico. A sedação resolve a consulta, mas não ensina a criança a aceitar o atendimento.

Por que a criança com TEA tem mais cárie?

Não é a condição: é higiene dependente do cuidador, hipersensibilidade oral, dieta seletiva e boca seca por medicamento.

O que muda por ser nível 3 e não nível 1?

A comunicação verbal é mínima, então o manejo se apoia em recurso visual e rotina, não em explicação falada. E a alteração sensorial é mais intensa, o que torna a adaptação do ambiente indispensável.

Estabilização protetora é o mesmo que imobilização?

Não. A estabilização é indicada, consentida, registrada e na técnica menos restritiva. Imobilizar sem indicação e sem consentimento é conduta inadequada.

Qual recurso vocês implantariam amanhã na clínica?

Agenda visual impressa e vídeo gravado no celular: custo quase zero e com ensaio clínico mostrando ganho de cooperação e redução do número de consultas.

O trabalho diz que não existe protocolo único. Então o que ele conclui?

Que a conduta é individualizada, mas os princípios são constantes: anamnese ampliada, previsibilidade, suporte visual, adaptação sensorial, reforço positivo e prevenção.